Note sur la dimension Santé

Pourquoi l'assurance maladie ne peut pas la porter seule

Pipeline `PythonIPM` — IPM Côte d'Ivoire, EHCVM 2021

Août 2026

Résumé

La dimension Santé de l'IPM ivoirien a d'abord reposé sur un unique indicateur — l'absence de couverture maladie — faute de pouvoir mesurer la mortalité juvénile dans l'EHCVM. Cette note montre pourquoi ce montage produisait un indice non plausible, expose le mécanisme arithmétique en cause, documente les décisions prises — l'ajout de l'insécurité alimentaire mesurée par l'échelle FIES de la FAO, puis celui du renoncement aux soins pour raison de coût ou d'indisponibilité de l'offre — et en mesure l'effet. Elle se termine sur ce qui reste ouvert.

1 Le point de départ

Le tableau de référence national place dans la dimension Santé un indicateur de **mortalité juvénile**. L'EHCVM 2021 ne permet pas de le construire : l'enquête n'a ni module décès ni historique des naissances. La base des chocs enregistre bien un « décès d'un membre du ménage » — 1 328 ménages sur trois ans, avec la date — mais **sans l'âge du défunt**. Il est donc impossible d'isoler les décès d'enfants de moins de dix-huit ans.

La dimension a d'abord été mesurée par un seul indicateur de substitution : *aucun membre du ménage n'est couvert par une assurance maladie*. Le choix se défendait — la question est renseignée pour 100 % des ménages, sans biais de sélection, et se lit sans ambiguïté.

2 Le problème

Avec quatre dimensions équipondérées à 0,25, un indicateur seul dans sa dimension **porte tout son poids**. Or 93,4 % des ménages ivoiriens n'ont aucun membre assuré. Trois conséquences en découlent, toutes arithmétiques et non statistiques.

2.1 L'indicateur dominait le score

L'assurance maladie apportait en moyenne **0,2336** sur un score moyen de 0,4603, soit **50,8 % du score de privation** à elle seule. Les douze autres indicateurs se partageaient l'autre moitié.

2.2 Elle fonctionnait comme un laissez-passer vers le seuil

Un ménage non assuré partait déjà à 0,25 sur les 0,3333 requis pour être déclaré pauvre. Deux privations de conditions de vie ($2 \times 0{,}0417 = 0{,}0833$) suffisaient alors à franchir exactement le seuil. **403 ménages** se trouvaient dans ce cas précis, et 396 avaient un score exactement égal à k : un ménage sur trente basculait sur une différence de troisième décimale.

2.3 Le résultat n'était pas plausible

Une simulation retirant l'indicateur et renormalisant les poids donne :

Configuration	H **(population pauvre)**
Treize indicateurs, assurance seule en Santé	79,7 %
Les mêmes, sans l'assurance maladie	45,7 %

Le second ordre de grandeur est celui publié pour la Côte d'Ivoire dans la table globale de l'OPHI. Le premier ne l'est pas.

Le fond du problème

Un indicateur qui prive 93 % de la population ne discrimine plus : il déplace le niveau de l'indice sans rien apprendre sur *qui* est pauvre. Ce n'était pas une erreur de calcul — le code appliquait fidèlement les choix actés — mais la rencontre de deux décisions qui se combinent mal : substituer l'assurance maladie à la mortalité juvénile, *et* conserver quatre dimensions équipondérées.

3 La décision

Un **second indicateur** a été ajouté à la dimension Santé : l'insécurité alimentaire mesurée par l'échelle **FIES** (*Food Insecurity Experience Scale*) de la FAO, présente dans la section 8A de l'EHCVM. Huit questions oui/non portant sur les douze derniers mois, ordonnées par sévérité croissante, dont le nombre de « oui » forme un score de 0 à 8.

#	Question	Sévérité
1	inquiétude de manquer de nourriture	légère
2	n'a pas pu manger sain et nutritif	légère
3	a mangé peu varié	légère
4	a sauté un repas	modérée
5	a mangé moins que nécessaire	modérée
6	plus de nourriture dans le ménage	modérée
7	a eu faim sans manger	sévère
8	est resté une journée entière sans manger	sévère

Le seuil retenu est **score** ≥ 4, qui correspond à l'insécurité alimentaire modérée ou sévère — le seuil standardisé de l'**indicateur ODD 2.1.2**. Il n'a donc pas fallu inventer un seuil : celui-ci est comparable aux publications de la FAO.

3.1 Pourquoi cet indicateur plutôt qu'un autre

La justification est de fond, et pas seulement d'opportunité. Dans l'IPM mondial, la dimension Santé est composée de la **nutrition** et de la mortalité juvénile. Remplacer la seconde — impossible à mesurer ici — par une mesure de la première ne dénature pas la dimension : c'est son autre pilier officiel.

S'y ajoute une raison statistique. La distribution du score FIES le sépare nettement de l'assurance maladie :

Score FIES	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Part des ménages	30,5	7,5	7,8	10,1	9,2	9,8	7,9	8,5	7,4

Un tiers des ménages à zéro, le reste étalé sur toute l'échelle. L'assurance maladie, elle, oppose 93,4 % à 6,6 % : elle sépare mal parce qu'elle ne varie presque pas. C'est exactement ce qu'on demande à un indicateur de privation — séparer — et c'est ce que le FIES fait.

Le taux de privation retenu s'établit à **42,7 % des ménages**, soit 40,8 % de la population.

4 Le troisième indicateur : le renoncement aux soins

Un **troisième indicateur** a ensuite été ajouté à la dimension : un ménage est privé si l'un de ses membres a eu un problème de santé dans les 30 derniers jours (question 3.01), n'a *pas* consulté (3.05) et a cité comme raison principale (3.06) soit le **coût** (« trop cher », « manque d'argent »), soit l'**indisponibilité de l'offre** de soins (« service spécialisé non disponible », « absence de personnel »).

Ces quatre modalités ont en commun d'être **subies**. Elles s'opposent aux motifs qui relèvent d'un arbitrage du ménage — l'automédication, le « pas nécessaire », la peur du résultat — lesquels ne rendent pas privé : renoncer parce qu'on juge la consultation inutile n'est pas la même chose que renoncer parce qu'on n'en a pas les moyens ou qu'il n'y a personne pour soigner.

Là où l'assurance maladie mesure une *couverture* formelle — largement absente en Côte d'Ivoire, donc peu discriminante — le renoncement aux soins mesure un **accès effectif empêché**, par l'argent ou par l'absence de service. C'est un fait, pas un droit théorique : le ménage a été malade, et n'a pas pu se soigner. L'indicateur prive **9,3 % des ménages** (9,0 % de la population). Il ne peut être privé que parmi les 67,2 % de ménages ayant connu un problème de santé sur la période : un ménage où personne n'a été malade n'est pas privé.

Le coût domine très largement

Les deux motifs d'offre sont rares : sur les 1 720 personnes qui renoncent, 1 706 le font pour une raison d'argent et 14 seulement pour indisponibilité du service ou absence de personnel. Les inclure n'ajoute que 10 ménages privés sur 12 965 et déplace l'M_0 de 0,000079. Le choix relève donc de la *définition* — un renoncement subi reste un renoncement subi, quelle qu'en soit la cause — et non d'un effet sur les résultats.

5 L'effet mesuré

La dimension Santé compte désormais trois indicateurs à **0,0833** chacun : le poids de l'assurance maladie est le tiers de ce qu'il était.

	Avant (assurance seule)	**Étape 2** (+ FIES)	**Aujourd'hui** (+ renoncement)
Indicateurs de l'IPM	13	13	16
Poids de l'assurance maladie	0,2500	0,1250	0,0833
Part de l'assurance dans le score moyen	50,8 %	29,4 %	19,9 %
Score moyen c_i	0,4603	0,3968	0,3918
H — **incidence**	**79,7 %**	**65,8 %**	**58,0 %**
Vulnérables	12,7 %	19,1 %	22,8 %
Pauvreté sévère	44,0 %	26,8 %	26,1 %
Ménages au score exactement égal à k	396	928	16

La colonne « Aujourd'hui » n'isole pas le seul effet du renoncement aux soins : elle intègre les trois indicateurs ajoutés en même temps (renoncement, emploi agricole de subsistance, promiscuité), qui font passer l'IPM de treize à seize indicateurs.

L'effet est net sur la pauvreté sévère, qui passe de 44,0 % à 26,1 % : c'est là que la domination d'un indicateur unique se voyait le plus. La dimension Santé, qui pesait 40,5 % de l'M_0 pour un poids nominal de 25 %, en pèse désormais **27,9 %** — l'assurance maladie 16,7 %, l'insécurité alimentaire 9,0 %, le renoncement aux soins 2,2 %.

6 Limites assumées

Le FIES n'est pas une mesure d'état nutritionnel.
Il mesure l'insécurité alimentaire *vécue*. L'OPHI, lui, mesure la nutrition par l'anthropométrie — indice de masse corporelle des adultes, retard de croissance des enfants. L'EHCVM n'a pas de module anthropométrique : le FIES est le meilleur substitut disponible, pas un équivalent.

C'est du déclaratif rétrospectif sur douze mois.
Il est donc sensible à la saison de collecte. Les deux vagues de l'EHCVM ayant été collectées à des saisons différentes, une vérification de la comparabilité entre vagues reste à mener.

195 ménages (1,5 %) n'ont pas de score complet
, pour cause de non-réponse ou de refus sur au moins un des huit items. Ils sont traités comme non privés, conformément à la convention générale du pipeline. C'est un choix — celui de ne pas pénaliser un refus de répondre — et non une déduction.

7 Ce qui reste ouvert

$H = 58{,}0$ % demeure au-dessus de l'ordre de grandeur de référence

L'assurance maladie pèse encore **16,7 % de l'IPM** — la deuxième contribution de tout le système — pour un indicateur qui prive 93 % des ménages. Trois leviers restent disponibles, non tranchés à ce jour.

1. **Abandonner l'assurance maladie** et garder le FIES et le renoncement aux soins en Santé. Cohérent avec le constat qu'un indicateur à 93 % n'informe pas ; la dimension garderait cette fois deux jambes, ce qui n'était pas le cas au moment du premier arbitrage.
2. **Rééquilibrer les dimensions.** Rien n'oblige à quatre dimensions égales. L'IPM mondial en retient trois — Santé, Éducation, Niveau de vie — à un tiers chacune.
3. **Revoir d'autres seuils dans le même esprit.** L'année de scolarité (72,5 %), l'énergie de cuisson (76,8 %) et les toilettes (77,3 %) privent aussi une large majorité des ménages, et posent la même question de pouvoir discriminant. Le cas s'est reproduit hors Santé : l'emploi agricole de subsistance prive 48,1 % des ménages et apporte à lui seul 16,9 % de l'M_0, contre 1,6 % au chômage, à poids identique.

Ces arbitrages relèvent du cadrage et non de la technique : chacun se modifie en une ligne dans `pipeline/02_construction_matrice_situationnelle.py`.